

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

INVENTARIO DE DELIRIOS DE PETERS — 21 ÍTEMS (PDI-21)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Evaluación Multidimensional de Ideación Delirante y Fenotipo Psicótico Continuo

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Inventario de Delirios de Peters de 21 Ítems (PDI-21).
Nombre Original (Inglés)	<i>Peters et al. Delusions Inventory - 21 Item Version (PDI-21)</i>
Autores Originales	Emmanuelle Peters, Stephen Joseph, Sam Day y Philippa Garety (2004), King's College London.
Adaptaciones Españolas	Fonseca-Pedrero et al. (2012, Universidad de La Rioja / CIBERSAM); López-Ilundain et al. (2006).
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Evaluación de ideación inusual, esquizotipia y estados de riesgo.
Tipo de Instrumento	Autoinforme de 21 reactivos dicotómicos con subescalas condicionales de Angustia, Preocupación y Convicción.
Población y Rango	Jóvenes y adultos (≥ 15 años). Cribado de psicosis incipiente, investigación de esquizotipia y clínica.
Tiempo de Administración	8 a 15 minutos.
Régimen de Licencia	Dominio público para fines de investigación académica y práctica clínica no comercial.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO CONTINUO DE PSICOSIS

El PDI-21 fue diseñado por Peters y colaboradoras (2004) en el marco del **modelo del continuum de la psicosis**, superando la visión categorial tradicional que concebía el delirio como un fenómeno dicotómico y exclusivo de la esquizofrenia. Este enfoque postula que las creencias inusuales existen a lo largo de un gradiente continuo desde la población no clínica hasta los cuadros psicóticos francos.

La innovación metodológica determinante del PDI-21 consiste en descomponer la creencia no sólo por su contenido temático, sino mediante tres **dimensiones cuantitativas de impacto**: el nivel de **angustia subjetiva** (distrés emocional), el grado de **preocupación** (tiempo de rumiación e intrusión atencional) y la fuerza de la **convicción** (certeza inquebrantable e impermeabilidad a la evidencia). Este diseño permite discriminar entre experiencias esquizotípicas inocuas o adaptativas y aquellas asociadas a disfunción clínica o sufrimiento.

3. DIMENSIONES EVALUADAS EN EL PDI-21 (PETERS ET AL., 2004)

Dimensión Evaluada	Ítems	Rango Dir.	Contenido y Significación Fenomenológica
1. Puntuación Sí / No	1 al 21	0 a 21	Conteo total de creencias anómalas o inusuales suscritas (paranoia, referencia, magia, influencia).
2. Angustia (Distress)	Condicional	0 a 105	Grado de malestar, sufrimiento psíquico y temor causado por las creencias afirmativas (1 a 5 por ítem).
3. Preocupación	Condicional	0 a 105	Tiempo y esfuerzo mental ocupado por la rumiación de las ideas delirantes (1 a 5 por ítem).
4. Convicción	Condicional	0 a 105	Grado de certeza objetiva e irreductibilidad de la creencia (1 a 5 por ítem).
PUNTUACIÓN GLOBAL PDI	Compuesta	0 a 336	Índice multidimensional integral de gravedad de la ideación delirante (Sí/No + Tres dimensiones).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA

Consistencia Interna	Elevada homogeneidad en muestras españolas (Fonseca-Pedrero et al., 2012): alfa de Cronbach de 0.82 para la escala Sí/No, 0.84 para Angustia, 0.85 para Preocupación y 0.86 para Convicción.
Fiabilidad Test-Retest	Coefficientes de estabilidad temporal $r = 0.78$ a 0.83 en un intervalo de cuatro a seis semanas.
Validez Discriminante	Diferencia de forma contundente entre sujetos no clínicos, grupos de Alto Riesgo Clínico de Psicosis (CHR-P) y pacientes con Primeros Episodios Psicóticos (FEP).
Validez Convergente	Correlación positiva y robusta con la subescala positiva del CAPE-42 ($r = 0.72$) y con las escalas de ideación mágica y pensamiento paranoide de Chapman ($r = 0.68$).
Invarianza Estructural	Invarianza métrica demostrada a través del sexo y diferentes cohortes de edad en adolescentes y adultos jóvenes.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN MULTIDIMENSIONAL

El protocolo se corrige secuencialmente para cada uno de los 21 enunciados:

- **Respuesta Dicotómica Inicial:** Si responde **NO**, se asigna **0 puntos** en todas las dimensiones de ese ítem.
- **Subescalas Dimensionales:** Si responde **SÍ**, se puntúa **1 punto** para el conteo Sí/No, y el sujeto califica las 3 subescalas de 1 a 5 puntos cada una:

Angustia (1 a 5) | Preocupación (1 a 5) | Convicción (1 a 5)

- **Totales Parciales:** Se suman independientemente: Conteo Sí/No (0–21), Angustia (0–105), Preocupación (0–105) y Convicción (0–105). La suma total da la **Puntuación Global PDI-21 (0–336)**.

6. BAREMOS Y ESTRATIFICACIÓN POBLACIONAL (FONSECA-PEDRERO ET AL., 2012)

Nivel Clínico	Total PDI	Población / Estado	Conducta Asistencial Recomendada
Normal Basal	0 a 30	Población general habitual	Ideación inusual esporádica sin impacto afectivo ni interferencia. No requiere intervención.
Esquizotipia	31 a 70	Esquizotipia benigna / Rasgo	Creencias atípicas pero con baja angustia o baja convicción. Observación evolutiva en adolescentes.
Alto Riesgo (CHR)	71 a 130	Sospecha de Estado Prodrómico	Elevada preocupación y distrés emocional. Cribado estructurado (SIPS / CAARMS) y seguimiento preventivo.
Psicosis Franca	≥ 131	Episodio Psicótico Activo	Convicción irreductible, sufrimiento extremo e interferencia vital severa. Derivación urgente a Salud Mental.

EL PAPEL CLAVE DE LA ANGUSTIA Y LA PREOCUPACIÓN: Las investigaciones con el PDI-21 demuestran que las personas de la población general pueden puntuar alto en número de creencias inusuales (p. ej., telepatía, signos astrológicos), pero presentan puntuaciones mínimas en angustia y preocupación. La transición a psicosis clínica está mediada principalmente por el aumento del sufrimiento afectivo y la intrusión rumiante continua.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA EN PSICOSIS TEMPRANA

DISCRIMINACIÓN FENOMENOLÓGICA Y CRITERIO DE INTERVENCIÓN:

- **Perfil Esquizotípico no Clínico:** Conteo Si/No moderado-alto (6–12), pero con Angustia media < 2.5 por ítem y baja convicción; el sujeto conserva distanciamiento crítico (“a veces pienso que me miran, pero sé que son imaginaciones mías”). No patologizar.
- **Perfil Clínico Prodrómico / Psicótico:** Presencia de paranoia, referencia o vivencias de pasividad con Angustia $ge \frac{4}{5}$ y Preocupación permanente. El paciente no puede desengancharse de la creencia, abandonando actividades cotidianas. Requiere intervención cognitivo-conductual para psicosis (CBTp) y valoración antipsicótica.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN ATENCIÓN TEMPRANA

Paciente: Joven de 20 años, estudiante universitario de informática, derivado por el servicio psicopedagógico debido a aislamiento social progresivo, caída brusca del rendimiento académico y tapar con cinta adhesiva las cámaras de todos sus dispositivos por sospecha de espionaje.

Resultados PDI-21:

- **Puntuación Global:** 158 puntos (Rango de Psicosis Franca / Alto Riesgo Crítico).
- **Desglose dimensional:** Conteo Si/No = 13/21; Angustia = 48/65 (puntuaciones de 4 y 5 en ítems de persecución y referencia); Preocupación = 52/65 (rumiación ininterrumpida); Convicción = 45/65 (convicción casi inamovible de que agentes externos monitorizan sus códigos).

Conducta Asistencial: Se diagnostica Primer Episodio Psicótico sin antecedentes toxicológicos. Se deriva de urgencia a la Unidad de Intervención Temprana en Psicosis, instaurando tratamiento con aripiprazol oral y terapia psicológica CBTp focalizada en normalización de experiencias anómalas y verificación de hipótesis alternativas. A las 8 semanas, el PDI-21 descendió a 42 puntos, con remisión del malestar angustioso y recuperación de la vida académica.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DERIVACIÓN URGENTE

ALERTA: DELIRIOS PERSECUTORIOS AGUDOS

Ítems afirmativos con máxima convicción en amenaza paranoide (“quieren hacerme daño físico grave”) conllevan riesgo inminente de conductas autodefensivas violentas o suicidio por escape. Derivación inmediata.

RIESGO TOXICOLÓGICO Y ORGÁNICO

En adolescentes y jóvenes con debut brusco de ideación delirante, debe descartarse el consumo de cannabis/estimulantes o encefalitis autoinmunes (anticuerpos anti-NMDAR).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Peters, E., Joseph, S., Day, S., & Garety, P. (2004). Measuring delusional ideation in the general population: A 21-item version of the PDI with scales of distress, preoccupation and conviction. *Schizophrenia Bulletin*, 30(4), 1005–1022.
2. Fonseca-Pedrero, E., Paino, M., Lemos-Giráldez, S., & Muñiz, J. (2012). Validation of the 21-item Peters et al. Delusions Inventory in Spanish adolescents and young adults. *Schizophrenia Research*, 135(1-3), 200–201.
3. López-Illundáin, J. M., Pérez-Nievas, F., Bagney, A., Ballesteros, A., & Rodríguez-Jiménez, R. (2006). Validación de la versión española del Inventario de Delirios de Peters (PDI-21). *Actas Españolas de Psiquiatría*, 34(6), 378–384.
4. Garety, P. A., & Freeman, D. (2013). The past and future of the cognitive approach to delusions: from psychology to psychopathology. *British Journal of Clinical Psychology*, 52(1), 1–21.